



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صباح جوده محمود الحسيكي
المحافظة : الجيزة
رقم البطاقة : 26902092101748 رقم التليفون : 01224266491
العنوان : السمان
العمر (تاريخ الميلاد) : 09-02-1969 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 01-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
جهة العلاج :
ملاحظات :
قسم :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صباح جوده محمود الحسيكي National ID: 26902092101748	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠٣٥/٠٤ - ٢٠٢٩-٠٣-٢١ ١٧٤٨
ربة منزل

اللقب: مسيلة

الجنس: صبرى محمد بطون الحسنى

المنطقة: سارية حتى ٢٠٣٢/٠٤/٢٣



دولة فلسطين
مملكة فلسطين

صباح

جوده محمد الحسنى

١٥ من الاغسطس سنة ١٤٤١

الجنس: المذكر

٢٠٢٩-٠٣-٢١ ١٧٤٨

LC6113826


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحديد الشخصية
 صباح
 جوده محمود الحسيني
 ١٥ ش الازهرى - قرية الصمد
 الهرم - الجيزة
 ٢٩٩.٢.٩٢١.١٧٤٨
 LC6113824


 ٢.٢٥/٠٤/٢٩٩.٢.٩٢١.١٧٤٨
 ربة منزل
 أنش
 صبرى محمد مكيون الحسيني
 البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/٠٤/٢٢




Name: صباح جودة محمود		
MR. : 4410		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 57-year-old individual with right-sided breast cancer, clinical stage T4b N3b M0, invasive ductal carcinoma, grade II. Hormone receptor testing showed estrogen receptor 8/8 positive, progesterone receptor 4/8 positive, HER2 negative (2-ve), and Ki-67 20 %. Neoadjuvant chemotherapy was administered consisting of 4 cycles of anthracycline (AC) followed by 4 cycles of taxane (TXT). The patient subsequently underwent right modified radical mastectomy (MRM) on 15 August 2024, with pathology reporting ypT1 ypN2 and involvement of 4 of 5 lymph nodes. A port-a-cath was placed in September 2024. Follow-up imaging in August 2025 demonstrated a free chest CT, and a breast ultrasound was performed. The patient is currently receiving tamoxifen (FEMARA) for a duration of three months. The plan is to continue ongoing hormonal therapy and routine surveillance as clinically indicated.		
تحريراً في ,		
	الوقت :	التاريخ : 20-09-2026
	إيه مدحت بدوي محمد	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / صباح جوده محمود	Request No. : 13005584
Patient No. : 26902092101748	Request Date : 10/09/2023
Path No. : 3056/23	Verification Date : 25/09/2023
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 54 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data

Right breast mass

Nature of specimen

Tru cut biopsy, collected at 10/9/2023, 10:30 am

Gross examination

Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench

Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- * Perineural invasion: No
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Intermediate nuclear reaction in tumor cells (Allred score 4/8)
- * HER2: No membrane reaction in of tumor cells (score 0)
- * Ki 67: 20 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis

Right breast mass, Tru cut biopsy:

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 10/10/2023 10:33:58

Page 1 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss

العينة



Patient Name : الأستاذة / صباح جوده محمود	Request No. : 13001885
Patient No. : 26902092101748	Request Date : 15/08/2024
Path No. : 2949/24	Verification Date : 28/08/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 55 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer post NACT .

Nature of the specimen: Right breast & right axilla (MRM)

Gross Examination:

- Procedure: Right MRM
measured 26x16x4.5 cm with covering skin ellipse measured 21x11 cm .
- Localization: UOQ
- Tumor extent : A greyish white tumour bed site
- Size: 1.8 x1.7 xo.5 cm .
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly .
- Distance from margins: 0.3 cm away from deep margin
- Axilla : Fibrofatty tissue piece measured 7x6 cm, entangling 5 nodules up to 1.5x0.5cm
- Microscopic examination:
- Histological type: Residual Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: Focal (3%)
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Positive L.Ns (4/5) with extracapsular extension
- Perineural invasion : Positive
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response
- Additional pathologica findings: Positive for microcalcifications

Diagnosis:

Right MRM (post NACT) :

Residual Invasive duct carcinoma grade II

- DCIS
- Free margins

Verified by :

Dr.Heba Hasan





Patient Name : الأستاذة / صباح جوده محمود	Request No. : 13001885
Patient No. : 26902092101748	Request Date : 15/08/2024
Path No. : 2949/24	Verification Date : 28/08/2024
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبادره
Age : 55 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Free nipple and areola
- Positive lymphovascular emboli
- Positive perineural invasion
- Positive L.Ns (4/5) with extraapsular extension
- Pathologic partial response
- Stage : ypT2 , ypN2a
- RCB : 3.425 , RCB class III

Signature

Dr.Salma Tarek

Dr.Heba Hassan

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 08/09/2024 09:17:48

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name: Sabah Goda Mahmoud Alhsiki	Date : 31/10/2023
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 3855/2023	Pat. ID: 42972

**DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND
COMPLEMENTARY ULTRASOUND**

Indication:

Right breast pathologically proven malignant mass

Report:

- ACR b: scattered fibroglandular parenchyma
- Right Breast:
 - Confluent Irregular ill-defined dense spiculated masses seen in the lower quadrants over an area measuring 67x64x53mm. Overlying skin thickening is noted. No overlying microcalcification.
 - Ultrasound shows confluent irregular heterogenous infiltrative inter-connected masses occupying the lower quadrants from 5-8 o'clock and reaching the nipple.
 - Multiple pathologically enlarged level I axillary lymph nodes are noted showing thick cortices and effaced hila
 - A globular supraclavicular lymph node is noted with effaced hilum measuring 7x6mm.
- Left Breast:
 - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
 - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
 - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
 - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Pathologically proven right breast malignant mass and level I axillary and supra-clavicular lymphadenopathy (BIRADS 6)
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1)

Best regards,

Dr Muzainah Ali

Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCI, Cairo University

31/10/2023 4:21 PM



Patient Name: Sabah Goda Mahmoud Alhsiki	Date : 14/10/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 3855/2023	

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -**

1. Chest:

- Right breast retroareolar and LIQ irregular speculated mass lesions the largest is measuring 3.5 X 1.8 cm.
- right axillary level I and II pathologically enlarged lymph nodes the largest measures 2.2 cm.
- enlarged right internal mammary lymph node seen measuring 2.5 X 1 cm.
- Few bilateral scattered tiny pulmonary nodules reaching 2 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes. Left renal cortical cyst.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

3. The scanned skeleton:



Patient Name: Sabah Goda Mahmoud Alhsiki	Date : 14/10/2023
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 54 Year(s)
Medical ID: 3855/2023	

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- D4 tiny lytic lesion is noted measuring 5 mm.
- L4 lytic grade I spondylolisthesis.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- *Right breast multicentric malignant looking mass lesions with pathological ipsilateral axillary and internal mammary lymph nodes as described.*
- *Bilateral scattered tiny pulmonary nodules likely benign in nature for follow up.*
- *D4 lytic lesion for bone scan.*
- *No definite hepatic metastatic deposits.*

Dr.Mohammed Mohsen, MSc.

Dr. Ola Magdy, M.D.

